Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Kommission für Fragen zu sexuell übertragbaren Infektionen (EKSI)

Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles (CFIST)

Commissione federale per le questioni relative alle infezioni sessualmente trasmissibili (CFIST)

Utilisation de la doxycycline en prophylaxie post-exposition (DoxyPEP) pour prévenir les infections sexuellement transmissibles en Suisse : recommandations de la Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles (CFIST)

19.03.2026

Informations concernant la DoxyPEP et genèse des présentes recommandations

La DoxyPEP désigne l'utilisation de la **doxycycline en prophylaxie post-exposition. Ce traitement préventif intervient après des relations sexuelles sans préservatif** afin de réduire le risque de contracter une **infection sexuellement transmissible (IST)**.

Depuis déjà quelques années, les professionnels de la santé en Suisse observent une augmentation de la demande en DoxyPEP de la part d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH). Souvent, ces personnes ont été informées de ce traitement par le biais de recommandations en vigueur dans d'autres pays. À l'heure actuelle, la DoxyPEP est en partie obtenue sans prescription médicale, par exemple sur Internet. Les réserves émises quant à l'utilisation de la doxycycline en PEP pour prévenir les IST concernent le développement de bactéries résistantes aux antibiotiques (bactéries responsables des IST et autres bactéries) et les effets indésirables sur le microbiome.

Dans la pratique, il existe une incertitude autour de l'utilisation de la DoxyPEP pour prévenir les IST, et les professionnels de la santé ont formulé le souhait de disposer de recommandations en la matière. Pour réduire cette incertitude et limiter l'utilisation incontrôlée de la DoxyPEP en dehors du système de santé, la CFIST a élaboré les présentes recommandations. Celles-ci visent à aider les professionnels de la santé à opter ou non pour la prescription de la DoxyPEP.

État des lieux de la recherche

Diminution des IST

Une méta-analyse publiée en 2025 fait le point sur l'état de la recherche et évalue la solidité des preuves (1). Cette méta-analyse de trois études contrôlées randomisées applicables à la Suisse et présentant un faible risque de distorsion aboutit aux résultats suivants pour le groupe des HSH et des femmes transgenres qui vivent avec le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou prennent la prophylaxie pré-exposition (PrEP) contre le VIH (1)(2)(3) **:**

- Sur 1000 personnes présentant un risque élevé de contracter une IST, la méta-analyse conclut que la DoxyPEP permet de réduire le nombre d'infections à *Chlamydia trachomatis* de 180 à 59 et d'infections à *Treponema pallidum* de 98 à 25 (risque relatif de 0,33 [intervalle de confiance, IC, à 95 % : 0,12-0,91) pour une infection à *Chlamydia*

trachomatis et risque relatif de 0,25 [IC 95 % : 0,12-0,49] pour une infection à *Treponema pallidum*).

- Selon la méta-analyse, l'utilisation de la DoxyPEP n'entraîne en revanche aucune réduction statistiquement significative des infections à gonocoques par rapport à sa non-utilisation (risque relatif de 0,87 ; IC 95 % : 0,49-1,55). À ce jour, seule une des études a pu mettre en évidence une diminution de ces infections étant donné que, dans de nombreux cas, *Neisseria gonorrhoeae* est déjà résistante à la doxycycline.
- Chez les femmes cisgenres, la seule étude menée à ce jour n'a démontré aucun bénéfice en raison de la faible adhésion des participantes à l'étude (4).

Au niveau populationnel, on observe une baisse des diagnostics de chlamydiose et de syphilis dans des régions où la DoxyPEP est déjà utilisée chez certains groupes de populations vulnérables (5).

Effets secondaires

Selon les études mentionnées ci-dessus, les effets indésirables les plus fréquents de la doxycycline sont les troubles gastro-intestinaux et les réactions cutanées (allergies, photosensibilisation). Ces effets concordent avec les données attestées de longue date s'agissant de l'utilisation de la doxycycline pour les infections, la prophylaxie antipaludique et le traitement de l'acné (1).

Développement de résistances

Les réserves émises quant à l'utilisation de la doxycycline pour la prophylaxie des IST concernent le développement de bactéries résistantes aux antibiotiques (bactéries responsables des IST et autres bactéries) et les effets indésirables sur le microbiome. En raison du faible nombre d'échantillons analysés, les études incluses dans la revue systématique de la littérature ne permettent pas de tirer de conclusions définitives sur le développement de résistances (1). Des études contrôlées non randomisées montrent une corrélation entre l'utilisation de la DoxyPEP et l'apparition de résistances chez *Neisseria gonorrhoeae*, notamment pour les lignées avec les allèles tetM et penA (association avec des résistances aux macrolides et aux céphalosporines), répandues à l'échelle mondiale. D'autres études décrivent le développement de résistances chez *Staphylococcus aureus* et d'autres bactéries pathogènes commensales (6)(7)(8).

Situation juridique

- En Suisse, la doxycycline n'est pas autorisée pour la prévention des IST et peut uniquement être prescrite hors étiquette (*off label*).
- Les coûts de la doxycycline sont à la charge des utilisateurs.

Élaboration des recommandations

L'orientation et la gradation des recommandations sont fondées sur les lignes directrices de l'Association des sociétés médicales scientifiques d'Allemagne (*Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften* [AWMF], v2.1, 13 septembre 2023, https://www.awmf.org/regelwerk/).

Tableau 1 : Degré de recommandation, formulation et signification

Symbole	Degré de recommandation	Formulation	Signification
↑↑	Très favorable	Doit être prescrit.	Vaut pour (presque) tous les patients, preuves scientifiques claires / rapport bénéfice-risque univoque.
↑	En partie favorable	Devrait être prescrit.	Vaut pour la plupart des patients, preuves scientifiques moins solides ou rapport bénéfice-risque moins net.
→	Neutre	Peut être envisagé.	Pas d'orientation claire, preuves scientifiques insuffisantes ou risques et bénéfices s'équilibrent.
↓	En partie défavorable	Ne devrait pas être prescrit.	En règle générale, non recommandé mais possible dans des cas particuliers.
↓↓	Très défavorable	Ne doit pas être prescrit.	Vaut pour (presque) tous les patients, preuves scientifiques nettement en défaveur de l'utilisation.

Recommandations de la CFIST concernant la DoxyPEP

Principes

- **La CFIST entend lutter contre l'utilisation incontrôlée de la DoxyPEP et formule des recommandations différenciées pour certains groupes de personnes (cf. tableau 2).**
- **La CFIST souligne l'importance des entretiens de conseil individuels avec un médecin, l'utilisation de la** DoxyPEP **devant être abordée avec certains groupes de personnes en même temps que d'autres mesures de prévention, en particulier la PrEP et la PEP VIH, le préservatif et la vaccination (cf. tableau 2)**.
- **En cas de prescription hors étiquette, il faut informer les personnes concernées des conséquences possibles, notamment des risques et des effets secondaires, et des effets incertains sur le microbiome et le développement de résistances. Cet entretien doit être documenté par écrit.**

Évaluation du rapport bénéfice-risque

- Au niveau individuel et sur la base des preuves à disposition pour certains groupes de personnes (cf. tableau 2), la CFIST considère que le bénéfice (diminution des IST) l'emporte sur les effets négatifs (effets secondaires).
- Au niveau populationnel, le rapport entre le bénéfice (diminution des IST) et les effets négatifs (effets secondaires, en particulier le développement de résistances) est pour l'heure incertain. La CFIST ne recommande pas l'utilisation généralisée de la DoxyPEP et différencie ses recommandations pour certains groupes de personnes (cf. tableau 2).

- Même si la DoxyPEP favorise le développement de résistances, la CFIST considère que l'impact sur la situation de l'antibiorésistance en Suisse est, en l'état actuel, minime. Seule une très faible part des groupes de personnes concernés par les présentes recommandations utilisera ou poursuivra cette antibiothérapie préventive. Le nombre attendu de personnes utilisant la DoxyPEP est très faible par rapport à l'utilisation générale de la doxycycline.
- Il importe néanmoins de souligner la difficulté d'évaluer l'impact aux niveaux local et national. Il est par conséquent indispensable de suivre attentivement la situation internationale et les résultats d'études internationales à large échelle. Des conséquences négatives ne pouvant être exclues, il convient de bien surveiller l'évolution, par exemple dans le cadre des études de cohorte en cours « SwissPrEPared » et « Swiss HIV Cohort Study » (SHCS).

Pour formuler ses recommandations en faveur ou en défaveur de la DoxyPEP (cf. tableau 2), la CFIST s'est fondée sur les données scientifiques exposées ci-dessus s'agissant de la diminution des IST grâce à la DoxyPEP, des effets secondaires et du développement de résistances, sur le volume attendu de prescriptions de DoxyPEP par rapport à l'utilisation générale de la doxycycline, sur la situation juridique et sur le contexte national et international (possibilité pour les personnes d'obtenir la DoxyPEP par leurs propres moyens et recommandations en vigueur dans d'autres pays). La CFIST a adopté ces recommandations au consensus (pas de vote formel) afin de réduire l'incertitude lors de la prescription et de limiter l'utilisation incontrôlée de la DoxyPEP.

Tableau 2 : Recommandations de la CFIST concernant l'utilisation de la DoxyPEP chez certains groupes de personnes

Groupes de personnes concernés	**Recommandation**	**Degré de recommandation**
• HSH ou femmes transgenres ayant des rapports sexuels avec des hommes **et** • ayant des rapports sexuels oraux, anaux ou vaginaux sans préservatif avec des partenaires différents[2] **et** • ayant contracté ≥ 1 IST bactérienne au cours des 12 derniers mois (date de l'indication ou du début de la DoxyPEP).	**La prescription de DoxyPEP devrait être proposée.** Possibilité de prescrire la DoxyPEP hors étiquette dans le cadre d'une prise de décision commune, en tenant compte des bénéfices et des coûts. Dans ce groupe, il convient de toujours proposer également une protection contre le VIH, par exemple la PrEP VIH ou la PEP VIH.	↑ **(en partie favorable)**
• HSM ou femmes transgenres pour lesquels l'indication ci-dessus ne s'applique pas, p. ex. personnes présentant un	**La prescription de DoxyPEP peut être envisagée.**	→ **(neutre)**

risque accru, mais n'ayant pas eu de diagnostic d'IST au cours des 12 derniers mois[4]. • Femmes cisgenres ayant eu des rapports sexuels sans préservatif avec des partenaires différents. • Hommes hétérosexuels ayant eu des rapports sexuels sans préservatif avec des partenaires différents. • Personnes ayant des rapports sexuels tarifés. • Personnes avec indication de PEP VIH. • Toutes les personnes victimes de viol.	Il n'existe pas d'études contrôlées randomisées attestant de l'efficacité de la DoxyPEP. Une utilisation hors étiquette peut être envisagée au cas par cas. Les personnes présentant un risque accru sont celles qui, notamment mais pas exclusivement, ont des rapports sexuels en groupe ou pratiquent le *chemsex*. Pour les personnes victimes de viol, la DoxyPEP peut être proposée en plus de la PEP VIH.	
Personnes ne présentant pas de risque accru d'IST bactériennes : • Personnes ayant une relation monogame. • Après un rapport sexuel avec préservatif. Contre-indications à la DoxyPEP : • Allergies et intolérances • Grossesse	**La prescription de DoxyPEP ne doit pas être proposée.**	↓↓ **(très défavorable)**

Utilisation :

- Prendre une dose unique de 200 mg de doxycycline, **dans la mesure du possible dans les 24 heures (max. 72 heures) suivant un contact sexuel sans préservatif.**
- Ne pas dépasser la dose de 200 mg par 24 heures (ne pas renouveler la prise en l'espace de 24 heures, même en cas de contacts sexuels avec plusieurs partenaires durant la même journée).
- Si le risque persiste, une prise de 200 mg de doxycycline toutes les 72 heures peut être envisagée.

Bibliographie

1. Molina JM, Charreau I, Chidiac C, Pialoux G, Cua E, Delaugerre C, et al. Post-exposure prophylaxis with doxycycline to prevent sexually transmitted infections in men who have sex with men: an open-label randomised substudy of the ANRS IPERGAY trial. Lancet Infect Dis. 2017/12/13 ed. 2018 Mar;18(3):308–17.
2. Molina JM, Bercot B, Assoumou L, Rubenstein E, Algarte-Genin M, Pialoux G, et al. Doxycycline prophylaxis and meningococcal group B vaccine to prevent bacterial sexually transmitted infections in France (ANRS 174 DOXYVAC): a multicentre, open-label, randomised trial with a 2 × 2 factorial design. The Lancet Infectious Diseases. 2024 Oct 11093–104.
3. Luetkemeyer AF, Donnell D, Dombrowski JC, Cohen S, Grabow C, Brown CE, et al. Postexposure Doxycycline to Prevent Bacterial Sexually Transmitted Infections. N Engl J Med. 2023 Apr 6;388(14):1296–306.
4. Stewart J, Oware K, Donnell D, Violette LR, Odoyo J, Soge OO, et al. Doxycycline Prophylaxis to Prevent Sexually Transmitted Infections in Women. N Engl J Med. 2023 Dec 21;389(25):2331–40.
5. Sankaran M, Glidden DV, Kohn RP, Nguyen TQ, Bacon O, Buchbinder SP, et al. Doxycycline Postexposure Prophylaxis and Sexually Transmitted Infection Trends. JAMA Internal Medicine. 2025 Mar 1;185(3):266–72.
6. Kong FYS, Kenyon C, Unemo M. Important considerations regarding the widespread use of doxycycline chemoprophylaxis against sexually transmitted infections. J Antimicrob Chemother. 2023 July 1 [;78(7):1561–8.
7. Vanbaelen T, Manoharan-Basil SS, Kenyon C. Four recent insights suggest the need for more refined methods to assess the resistogenicity of doxycycline post exposure prophylaxis. Current Research in Microbial Sciences. 2024 Jan 1 [;6:100234.
8. DeWitt ME, Wenner JJ, Bellotti BR, Manuel JA, Toler C, Palavecino E, et al. Promise and peril: doxycycline prophylaxis and the spread of resistance among diverse populations. The Lancet Microbe. 2025 Aug 22 [cited 2025 Oct 10];0(0).